American Heart Association

Suporte Avançado de de Vida Cardiovascular Exame A

13 de abril de 2021

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

Exame A de suporte avançado de vida cardiovascular

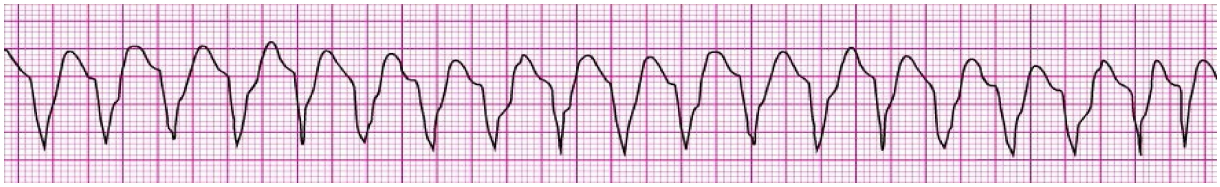
(50 perguntas)

Não faça marcações neste exame. Registre a melhor resposta na folha de respostas separada

1. Qual desses exames deve ser realizado, no caso de um paciente com suspeita de AVC, o mais rápido possível e não mais do que 20 minutos após a chegada ao hospital?

   A. ECG de 12 derivações
   B. Enzimas cardíacas
   C. Coagulograma
   D. Tomografia computadorizada de cabeça sem contraste

2. Qual das opções melhor descreve esse ritmo?



   A. Taquicardia ventricular monomórfica
   B. Taquicardia ventricular polimórfica
   C. Taquicardia supraventricular
   D. Fibrilação ventricular

3. Que método é recomendável para a escolha de uma via aérea orofaríngea de tamanho adequado?

   A. Medir do canto da boca até o ângulo da mandíbula
   B. Medir da cartilagem tireoidea até a parte inferior do lóbulo da orelha
   C. Fazer uma estimativa usando a fórmula Peso (kg)/8 + 2
   D. Fazer uma estimativa usando o tamanho do dedo do paciente

4. Você está cuidando de um paciente com suspeita de AVC cujos sintomas começaram 2 horas atrás. A tomografia computadorizada estava normal, sem sinais de hemorragia. O paciente não apresenta nenhuma contraindicação ao tratamento fibrinolítico. Qual a melhor abordagem de tratamento para este paciente?

   A. Manter o tratamento fibrinolítico por 24 horas
   B. Administrar tratamento fibrinolítico o mais cedo possível e considerar o tratamento endovascular
   C. Solicitar um ecocardiograma antes da administração de fibrinolíticos
   D. Aguardar os resultados da ressonância magnética

5. Qual a próxima etapa recomendável após uma tentativa de desfibrilação?

   A. Verificar se há evidências de ritmo organizado no ECG
   B. Abrir a via aérea do paciente
   C. Determinar se há pulso carotídeo
   D. Reiniciar a RCP pelas compressões torácicas

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

6. Qual dos seguintes sinais é uma provável indicação de PCR em um paciente que não responde?

   A. Frequência de pulso lenta e fraca
   B. Cianose
   C. Suspiro agonal
   D. Frequência do pulso irregular e fraca

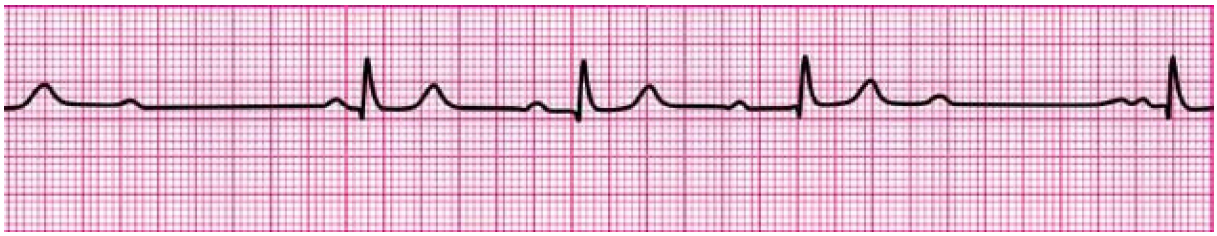
7. Você está avaliando um homem de 58 anos com desconforto torácico. A pressão arterial é 92/50 mmHg, a frequência cardíaca é 92 batimentos/min, a frequência respiratória é 14 incursões/min e a leitura de oximetria de pulso é 97%. Que etapa de avaliação é mais importante agora?

   A. Avaliar a leitura de PetCO2
   B. Solicitar uma radiografia do tórax
   C. Obter um ECG de 12 derivações
   D. Solicitar exames laboratoriais

8. Durante cuidados pós-PCR, qual é a duração recomendada do controle direcionado da temperatura, depois que se consegue obter a temperatura alvo definida?

   A. Pelo menos 8 horas
   B. Pelo menos 24 horas
   C. Pelo menos 36 horas
   D. Pelo menos 48 horas

9. Que tipo de bloqueio atrioventricular melhor descreve esse ritmo?



   A. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau
   B. Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I
   C. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau
   D. Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo II

10. Sua equipe de emergência pré-hospitalar encontra um homem de 59 anos deitado no chão da cozinha. Você verifica que ele não está respondendo. Qual é a próxima etapa em sua avaliação e tratamento desse paciente?

    A. Usar o DEA
    B. Verificar respiração e pulso do paciente
    C. Abrir a via aérea do paciente
    D. Verificar se o paciente está usando algum bracelete de alerta médico

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

Use este cenário para responder as seis perguntas a seguir:

Há 2 dias, um homem de 45 anos teve implantados stents em artéria coronária. Hoje, ele está sentindo dor intensa e relatando desconforto (“esmagamento”) no tórax. Ele está pálido e diaforético e com a pele fria ao toque. O pulso radial está bastante fraco, a pressão arterial é 64/40 mmHg, a frequência respiratória é 28 ventilações/min e a saturação de oxigênio é 89% no ar ambiente. No momento em que foi conectado, o monitor cardíaco evidenciou uma taquicardia ventricular, que rapidamente mudou para fibrilação ventricular.

11. Com base na apresentação inicial desse paciente, que quadro clínico você acredita que tenha desencadeado a PCR?

    A. Síndrome coronária aguda
    B. Insuficiência cardíaca aguda
    C. AVC isquêmico agudo
    D. Taquicardia supraventricular com dor torácica isquêmica

12. Além da desfibrilação, que intervenção deve ser realizada imediatamente?

    A. Obtenção de via aérea avançada
    B. Administração de medicação vasoativa
    C. Compressões torácicas
    D. Acesso vascular

13. A despeito duas tentativas de desfibrilação, o paciente continua em fibrilação ventricular. Que medicamento e que dose devem ser administrados primeiramente ao paciente?

    A. Epinefrina 1 mg
    B. Amiodarona 300 mg
    C. Lidocaína 1 mg/kg
    D. Atropina 1 mg

14. A despeito do medicamento administrado anteriormente e a continuidade da RCP, o paciente continua em fibrilação ventricular. Que outro medicamento deve ser administrado em seguida?

    A. Epinefrina 1 mg
    B. Atropina 1 mg
    C. Sulfato de magnésio 1 g
    D. Lidocaína 1 a 1,5 mg/kg

15. O paciente tem retorno da circulação espontânea e não consegue responder a comandos. Que intervenção pós-PCR imediata você escolhe para esse paciente?

    A. Iniciar o controle direcionado da temperatura
    B. Verificar o nível de glicemia
    C. Administrar epinefrina
    D. Extubar

16. O que você teria feito primeiro se o paciente não tivesse entrado em fibrilação ventricular?

    A. Estabelecido acesso IV
    B. Obtido um ECG de 12 derivações
    C. Administrado atropina 1 mg

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

D. Realizado cardioversão sincronizada

17. Como você pode aumentar a fração de compressões torácicas durante uma tentativa de ressuscitação?

    A. Carregue o desfibrilador 15 segundos antes de verificar o ritmo
    B. Troque o responsável pela ventilação pelo responsável pela compressão durante a verificação do ritmo
    C. Administre epinefrina durante o ciclo de 2 minutos
    D. Inicie o acesso intravenoso ou intraósseo durante o ciclo de 2 minutos

18. Um membro da equipe não consegue realizar uma tarefa que lhe foi atribuída porque está além de seu escopo de atuação. Que medida o membro da equipe deve tomar?

    A. Pedir uma nova tarefa ou função
    B. Atribuir essa tarefa a outro membro da equipe
    C. Realizá-la assim mesmo
    D. Consultar um especialista

19. Além da avaliação clínica, qual o método mais confiável para confirmar e monitorar o correto posicionamento de um tubo endotraqueal?

    A. Gasometria arterial
    B. Radiografia do tórax
    C. Capnografia com forma de onda contínua
    D. Níveis de hemoglobina

20. Seu paciente encontra-se em PCR e foi intubado. Para avaliar a qualidade da RCP, o que você deve fazer?

    A. Monitorar a PetCO2 do paciente
    B. Obter um ECG de 12 derivações
    C. Verificar o pulso do paciente
    D. Obter uma radiografia do tórax

21. Aos três minutos de uma tentativa de ressuscitação em uma PCR, um membro da equipe insere um tubo endotraqueal, enquanto outro aplica compressões torácicas. A capnografia mostra uma forma de onda persistente e PetCO2 de 8 mmHg. Qual o significado desse achado?

    A. As compressões torácicas talvez não sejam eficazes.
    B. O tubo endotraqueal está no esôfago.
    C. O paciente atende aos critérios para encerramento dos esforços.
    D. A equipe está ventilando o paciente com frequência muito elevada (hiperventilação).

22. Qual das opções melhor descreve esse ritmo?



    A. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

B. Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I
C. Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo II
D. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau

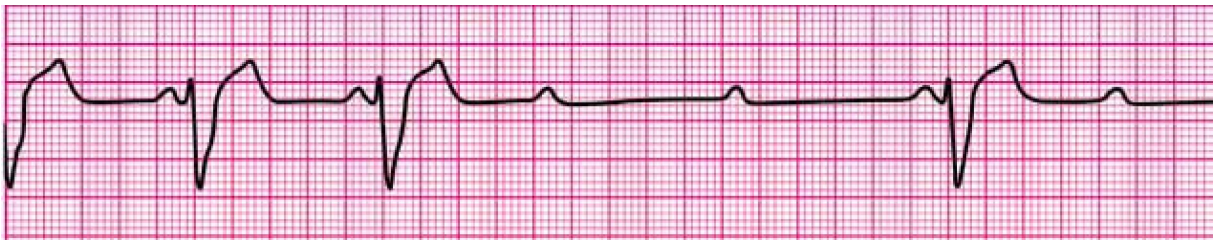
23. Supondo que um membro da equipe está para cometer um erro durante uma tentativa de ressuscitação; o que melhor descreve a medida que o líder da equipe ou outros membros da equipe devem tomar?

A. Conduzir uma desfibrilação após a tentativa de ressuscitação
B. Reatribuir as tarefas da equipe
C. Dirigir-se ao membro da equipe imediatamente
D. Afastar o membro da equipe do local

24. Um paciente com taquicardia de complexos estreitos estável, com acesso periférico IV já estabelecido, é refratário à primeira dose de adenosina. Que dose você deve administrar em seguida?

A. 3 mg
B. 12 mg
C. 20 mg
D. 40 mg

25. Que tipo de bloqueio atrioventricular melhor descreve esse ritmo?



A. Primeiro grau
B. Segundo grau tipo I
C. Segundo grau tipo II
D. Terceiro grau

26. Qual o objetivo principal de uma equipe de emergência médica (EEM) ou uma equipe de resposta rápida (ERR)?

A. Aprimorar o atendimento para pacientes hospitalizados em unidades de tratamento intensivo
B. Aprimorar a evolução do paciente identificando e tratando a deterioração clínica precoce
C. Fornecer consulta de diagnóstico para os pacientes do departamento de emergência
D. Fornecer consulta on-line com o pessoal do SME em campo

27. Um paciente está sendo ressuscitado em um ambiente bastante barulhento. Um membro da equipe acredita ter ouvido uma ordem de 500 mg de amiodarona IV. Qual a melhor resposta desse membro da equipe?

A. “OK.”
B. “Tem certeza?”
C. “Amiodarona 500 mg IV administrada.”
D. “Recebi a ordem para administrar 500 mg de amiodarona IV. Está correto?”

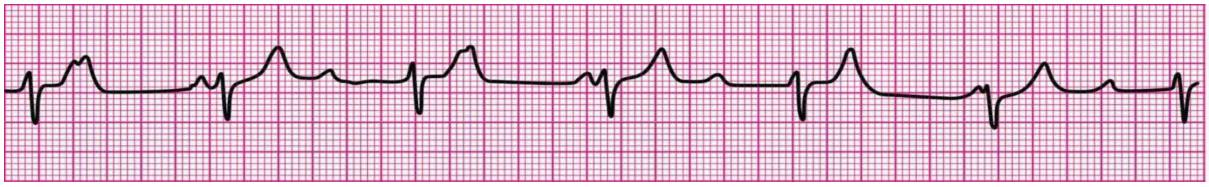
© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

28. Qual a dose oral recomendada de aspirina para um paciente com suspeita de síndrome coronária aguda?

    A. 40 mg
    B. 81 mg
    C. 162 a 325 mg
    D. 350 a 650 mg

29. Você realizou 2 minutos de RCP. O monitor de ECG exibe o ritmo II da derivação mostrada aqui e o paciente não tem pulso. Outro membro da equipe reinicia as compressões torácicas e o acesso IV é estabelecido. O que você faz em seguida?



    A. Inicia uma infusão de dopamina
    B. Administra atropina 0,5 mg
    C. Administra epinefrina 1 mg IV
    D. Obtém uma via aérea avançada

30. Qual a pressão arterial sistólica mínima que se deve tentar alcançar com a administração de fluidos ou de agentes vasoativos em um paciente hipotenso pós-PCR que obtém retorno da circulação espontânea?

    A. 75 mm Hg
    B. 80 mm Hg
    C. 85 mm Hg
    D. 90 mm Hg

31. Qual deve ser o foco principal do instrutor de RCP em uma equipe de ressuscitação?

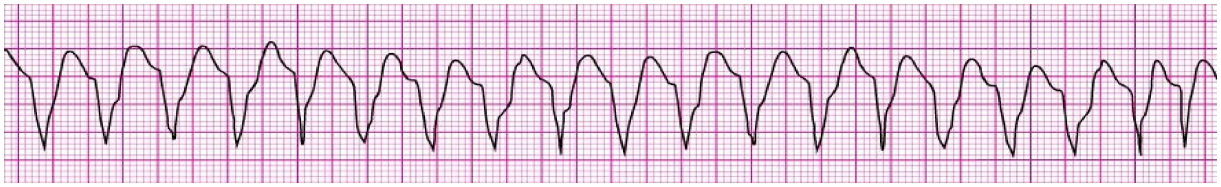
    A. Fornecer feedback positivo
    B. Garantir a RCP de alta qualidade
    C. Resolver discussões dentro da equipe
    D. Documentar os resultados da RCP

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

Use este cenário para responder às quatro perguntas a seguir:

Uma mulher de 68 anos de idade apresenta sensação de desfalecer, náusea e desconforto torácico. Em sua avaliação, você a encontra acordada e consciente, mas com aparência doente, pálida e excessivamente diaforética. Seu pulso radial é fraco, quase imperceptível e rápido. Você não consegue mensurar a pressão arterial. Ela não apresenta nenhum edema aparente óbvio, e as veias do pescoço não estão engurgitadas. Os sons pulmonares parecem equivalentes, com crepitações moderadas presentes bilateralmente. O monitor cardíaco evidencia o ritmo mostrado aqui.



32. Com base na avaliação inicial desse paciente, que algoritmo de SAVC deve ser seguido?

    A. Síndromes coronárias agudas
    B. Taquicardia com pulso para adultos
    C. Suspeita de AVC em adulto
    D. PCR em adulto

33. O oxímetro de pulso do paciente mostra uma leitura de 84% em ar ambiente. Que medida inicial você deve tomar?

    A. Realizar ventilação com bolsa-máscara
    B. Intubar o paciente
    C. Administrar oxigênio
    D. Verificar o conector do oxímetro de pulso

34. Após a avaliação inicial do paciente, que intervenção você deve fazer em seguida?

    A. A cardioversão sincronizada
    B. Administração de amiodarona 150 mg IM
    C. Desfibrilação imediata
    D. Intubação endotraqueal

35. Se o paciente ficar apneico e sem pulso, mas o ritmo permanecer o mesmo, o que teria prioridade mais alta?

    A. Administrar amiodarona 300 mg
    B. Administrar atropina 0,5 mg
    C. Obtém uma via aérea avançada
    D. Realizar desfibrilação

36. Você instrui um membro da equipe a administrar 1 mg de atropina IV. Que resposta é um exemplo de comunicação em circuito fechado?

    A. “Vou administrá-la daqui a alguns minutos.”
    B. “OK.”
    C. “Vou preparar uma dose de 1 mg e atropina.”
    D. “Você tem certeza de que é isso o que você deseja administrar?”

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

37. O que melhor descreve a medida tomada pelo líder da equipe para evitar ineficiência durante uma tentativa de ressuscitação?

A. Atribuir mais tarefas aos membros mais experientes da equipe
B. Executar as tarefas mais complexas
C. Delegar claramente as tarefas
D. Atribuir as mesmas tarefas a mais de um membro da equipe

38. Qual é um dos efeitos da ventilação excessiva?

A. Diminuição do débito cardíaco
B. Diminuição da pressão intratorácica
C. Elevação das pressões de perfusão
D. Elevação do retorno venoso

39. Que opção melhor descreve o tempo recomendado de verificação do pulso durante a avaliação de SBV?

A. 1 a 4 segundos
B. 5 a 10 segundos
C. 11 a 15 segundos
D. 16 a 20 segundos

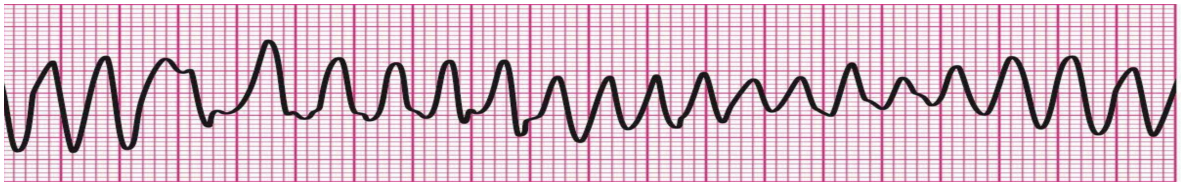
40. Qual é a primeira dose intravenosa recomendada de amiodarona para um paciente com fibrilação ventricular refratária?

A. 100 mg
B. 150 mg
C. 250 mg
D. 300 mg

41. Que instituição é um destino mais apropriado para o SME, no caso de um paciente em PCR que obteve retorno da circulação espontânea no pre-hospitalar ?

A. Unidade completa de tratamento de AVC
B. Unidade de tratamento de reabilitação aguda
C. Unidade de tratamento agudo de longo prazo
D. Centro médico com competência para tratamento de reperfusão coronária

42. Um paciente apresenta perda de consciência de forma presenciada. O ECG da derivação II revela este ritmo. Qual o tratamento apropriado?



A. Administração de adenosina 6 mg por bolus IV
B. Administração de epinefrina 1 mg por bolus IV
C. Desfibrilação
D. A cardioversão sincronizada

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

43. Em paciente com IAMST, o que melhor descreve o tempo máximo recomendado com relação ao tempo entre o primeiro contato médico e a insuflação do balão para uma intervenção coronária percutânea?

    A. 180 minutos
    B. 150 minutos
    C. 120 minutos
    D. 90 minutos

44. Você está administrando compressões torácicas durante uma tentativa de ressuscitação. Que frequência você deve usar para administra-las ?

    A. Inferior a 80/min
    B. 80 a 90/min
    C. 100 a 120/min
    D. Superior a 120/min

45. Que intervalo máximo você deve permitir para uma interrupção nas compressões torácicas?

    A. 10 segundos
    B. 15 segundos
    C. 20 segundos
    D. 25 segundos

46. Para ventilar apropriadamente um paciente perfusão (pulso presente), com que frequência você pressiona a bolsa?

    A. Uma vez a cada 3 segundos
    B. Uma vez a cada 6 segundos
    C. Uma vez a cada 10 segundos
    D. Uma vez a cada 12 segundos

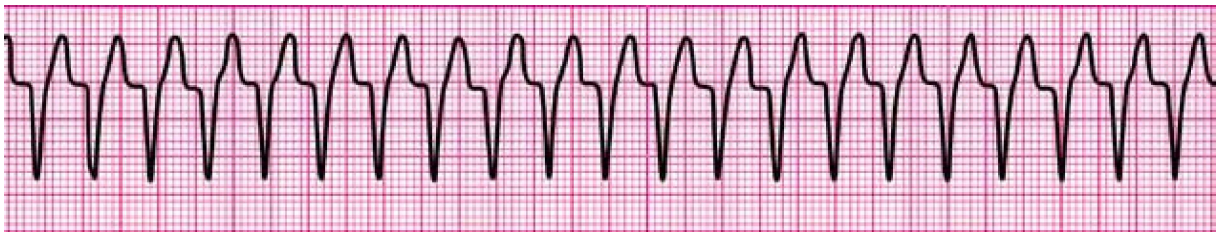
47. Os profissionais do SME estão tratando um paciente com suspeita de AVC. De acordo com o Algoritmo para suspeita de AVC em adultos, que ação crítica da equipe do SME agilizará o tratamento desse paciente na entrada e reduzirá o tempo de tratamento?

    A. Fornecer notificação prévia ao hospital
    B. Estabelecer o acesso IV
    C. Examinar o histórico do paciente
    D. Tratar a hipertensão

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)

48. O ECG de um paciente com desconforto respiratório e pressão arterial de 70/50 mmHg apresenta o ritmo da derivação II mostrado aqui. Qual o tratamento apropriado?

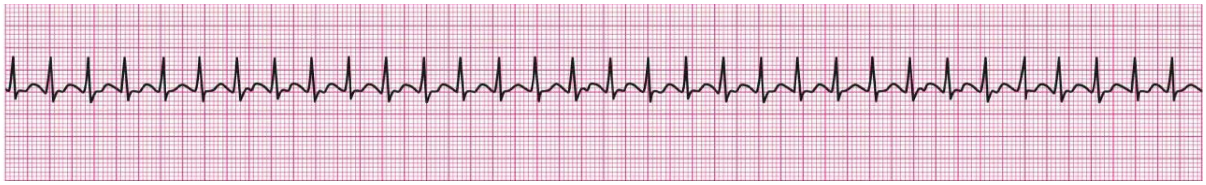


A. Administrar 6 mg de adenosina por bolus IV
B. Realizar cardioversão sincronizada
C. Realizar manobras vagais
D. Realizar desfibrilação

49. Com relação à escolha e manutenção constante de uma temperatura, que intervalo é recomendado para obter um controle direcionado da temperatura pós-PCR?

A. 26 °C a 28 °C
B. 29 °C a 31 °C
C. 32 °C a 36 °C
D. 35 °C a 37 °C

50. Um atendente está cuidando de um paciente com um histórico de insuficiência cardíaca congestiva. O paciente está apresentando falta de ar, pressão arterial de 68/50 mmHg e frequência cardíaca de 190/min. O ECG da derivação II do paciente é mostrado aqui. O que melhor caracteriza o ritmo desse paciente?



A. Taquicardia ventricular de perfusão
B. Taquicardia sinusal
C. Taquicardia supraventricular estável
D. Taquicardia supraventricular instável

© 2021 American Heart Association

Printed Apr 14, 2021 for Elizabete Santos, Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (ZL21394)